

주말 업데이트 비교 분석

생성 시각: 2026-04-26 05:35:34
비교 기간: 10/26 1-3교시 (부신히르몬 생리, 부신히르몬 종류/작용/평가, 부신히환)
신버전 정리족: [정리족]내분비학 1차 정리족(2).pdf
신버전 출족: [출족]내분비학 1차 출족(2).pdf

⚠ 교수 변경 — 비교 제외 수업

- ↔ **갑상선 증례**: CHANGED: 김미진 → 김보현
- ↔ **부신히 기능저하증**: CHANGED: 강아름 → 김상수
- ↔ **부신히 증례**: CHANGED: 강아름 → 김상수
- ↔ **부신히 질환**: NEW: 강양호
- ↔ **갑상선염**: REMOVED: 김보현
- ↔ **성분화 이상**: REMOVED: 이동원
- ↔ **쿠싱증후군**: REMOVED: 강양호
- ↔ **알도스테론혈증, 갈색세포종**: REMOVED: 강양호

전체 내용을 충분히 파악했습니다. 이제 비교 분석을 작성하겠습니다.

정리족 버전 비교 분석

비교 대상: 10/26 1-2교시 — 권상모 부신히르몬 생리 / 강양호 부신히르몬 종류·작용·평가
(부신히 질환/쿠싱/알도스테론혈증/갈색세포종/부신히기능저하증/부신히증례 등 교수 변경 수업은 건너뛴)

📄 구조 변화

항목	구버전(선배족)	신버전(올해)
파일 구성	정리족(2) 시작: 김보현-갑상선 호르몬과 평가	정리족(2) 시작: 권상모-갑상샘 호르몬 생리 신규 배치
부신히 질환계 섹션	쿠싱증후군 + 알도스테론혈증·갈색세포종 (2개로 분리)	부신히 질환 1개로 통합
갑상샘 기능 조절 약물	구버전 정리족(1) 말미에 존재	신버전 정리족(2)에 김치대 교수님 섹션 추가
	정리족(2)에 포함	삭제됨 (교수 변경)

항목	구버전(선배족)	신버전(올해)
갑상선염·성분화 이상		
강양호 섹션 번호	10번~26번으로 시작	1번~17번 으로 재편집

NEW 신버전에만 있는 새 내용

[1교시] 권상모 — 부신피로몬 생리

① HPA axis 흐름 도식화 (텍스트로 명시 추가)

시상하부 — CRH → 뇌하수체전엽 — ACTH → 부신 — 코티솔 → (HPA axis)

② 21-hydroxylase 교수님 퀴즈 추가 (구버전에 없음)

"(23교수님: CYP21A2 21-hydroxylase 효소에 mutation이 있을 때 이 아이의 증세는?
→ Aldosterone, cortisol이 결핍되는 문제발생..자세한 내용은 뒷시간에서~)"

③ 위축 효과(atrophy effect)에 구체적 기간 추가

"장기 glucocorticoid 치료 (**3주 넘게**)를 거쳐 위축 효과가 발생"
→ 구버전에는 "3주"라는 기간이 없었음

④ Stress Response 출제 기록 새로 추가

신버전: 9. Stress Response (2022출) — **작년에 출제된 내용임을 명시**
"(23교수님: 가장 중요한 pathway)" — CRH-ACTH-Cortisol pathway 직접 강조

⑤ Adrenal Medulla 카테콜아민 표현 변경

"보통 17:3의 비율로 **Adrenaline(Epinephrine)(major)**, Norepinephrine 생산" — "**major**" 강조 추가

⑥ Secondary hyperaldosteronism 설명 보강

"(비정상) **kidney로 가는 blood flow의 감소!!**" 추가 — 원인 메커니즘 명시

[2교시] 강양호 — 부신피로몬 종류, 작용, 평가

① Summary 표 형식으로 재구성 (구버전 = 글머리 나열 형식)

신버전은 Glucocorticoid vs Mineralocorticoid 각 Test를 표로 정리 + 각 검사가 어떤 질환에 쓰이는지 한눈에 요약

② 복습 퀴즈 정답 해설에 메커니즘 추가

"갑상샘 기능 저하 → TRH분비 증가 → **TSH뿐만 아니라 PRL도 증가시킴**" — 기억하기 쉽게 이유 추가

③ Low dose dexamethasone suppression test 기간 변경 ⚠️ 중요

- 구버전: "0.5mg 6시간 간격으로 **2일**에 걸쳐"
- 신버전: "0.5mg 6시간 간격으로 **3일정도**" — 기간이 2일 → 3일로 변경

④ High dose dexamethasone test 기간 구체화

"입원하여 low dose, high dose test를 연속해서 **6일동안** 시행" — 총 기간 명시

⑤ 쿠싱병 선별검사 교수님 선호 명시

"(23교수님: 저는 선별검사 이거 선호합니다.)" — 24h urinary free cortisol 옆에 추가

⑥ Tests for androgens에 새 항목 추가

"다. Carcinoma 생기면 전구체 level 높아지는데 **진단적 가치가 없다.**" — 구버전에 없던 내용

⑦ Primary aldosteronism K+ escape 보충

"K+는 escape phenomenon 없음. Hypokalemia 지속... **단, 무조건 나타나는건 아님**" — 구버전에 없던 단서

⑧ 2022년 출제 기록 대거 추가

- 부신 피질 호르몬 3종: [2022출] 추가
- 11 β -HSD: [2021-1, 2022출] 으로 갱신
- Low dose dexamethasone test: [2022출] 추가

✗ 구버전에서 삭제된 내용

삭제 항목	비고
강양호 파트 "10. 복습 Quiz → 26. 복습퀴즈"의 번호체계	1~17번으로 재편집, 내용은 보존
위축 효과 다이어그램 설명 일부 표현	

2. 위축 효과(Atrophy Effect) — 기간 "3주" 출제 가능

"3주 넘게"라는 구체적 수치가 신버전에 새로 추가됨. 강조도도 PPP→PPPPPPPP으로 폭발적 증가. 메커니즘 전체 흐름(exogenous steroid → HPA 억제 → zona fasciculata 위축 → 영구 불능)을 서술형으로 대비.

3. Low dose dexamethasone suppression test 기간 "3일"

구버전 2일 → 신버전 3일로 변경. 단순 암기 문제로 출제 가능성 높음.
(High dose도 "6일"로 명시됨 — 세트로 암기할 것)

4. 21-hydroxylase 퀴즈 형태 출제 가능

"(CYP21A2 mutation이 있을 때 증세?)" 라는 교수님 직접 언급 추가.
Aldosterone + Cortisol 결핍, DHEAS 과잉, 불임 흐름 전체 숙지.

5. Tests for androgens — Carcinoma 항목 신규

"Carcinoma 시 전구체 level 높지만 진단적 가치 없다"는 내용이 구버전에 없다가 신버전에 추가.

6. 강양호 Tests 섹션 — 어떤 질환에 어떤 검사? (PPP 폭발)

신버전에서 검사 선택 능력을 압도적으로 강조 (pp 수준).
핵심: Stimulation(분비 부족) vs Suppression(분비 과다) 구분 + 각 검사와 질환 매칭 완벽 암기.

요약: 올해 신버전의 가장 큰 변화는 ① **Stress Response의 출제 격상**, ② **위축 효과 기간 "3주" 추가**, ③ **Low dose dex test 기간 2일→3일 변경**, ④ **Tests 섹션 전체의 강조도 폭발적 증가**입니다. 서술형 10문제 출제 특성상 메커니즘 중심으로 공부하시길 강력 권장합니다.

이제 충분한 데이터가 확보되었습니다. 분석 결과를 작성합니다.

출족 버전 비교 분석

비교 대상: 구버전 선배족 1차 출족(1)(2)(3) ↔ 신버전 올해 출족(2)

★ **집중 범위:** 10/26 1-3교시 — 권상모 부신피하선 생리, 강양호 부신피하선 종류/작용/평가

NEW 신버전에 추가된 문제

★★★★ 권상모 - 부신피로몬 생리 (10/26 1교시)

Q23 [2022 신규 추가]

우리 몸에서 생리학적으로 발생하는 Generalized Stress Response에 대하여 필수 호르몬과 연계하여 4가지 카테고리로 설명해 보시오.

정답:

1. **Activation of sympathetic nervous system** + epinephrine secretion
2. **Activation of CRH-ACTH-cortisol system** → metabolic resources mobilization
3. **Elevation of blood glucose & fatty acids** → insulin ↓ / glucagon ↑
4. **Maintenance of blood volume & blood pressure** → renin-angiotensin-aldosterone system 활성화 + vasopressin ↑

📌 신버전 출제 작성자 코멘트: "올해는 후다닥 그냥 읽고 넘어간 부분이라 다른 부분에서 내시지 않을까 생각합니다" — 2024년 시험 출제 가능성은 낮게 봄, 하지만 범위로 포함됨.

★★★★ 강양호 - 부신피로몬 종류, 작용, 평가 (10/26 2교시)

Q35 [2022 신규 추가]

다음 부신피로몬 대사에 대한 내용 중 **옳은 것은?** (구버전 Q30·Q34와 유사하나 문제 방향 반전 — "틀린 것" → "옳은 것")

번호	보기	정오
①	Mineralocorticoids는 anti-inflammatory 작용을 한다	✗ (Glucocorticoids)
②	Cortisol은 mineralocorticoid receptor(MR)에 결합할 수 없다	✗ (결합 가능)
③	Androgens는 RAA system에 의해 조절된다	✗ (Glucocorticoids는 HPA)
④	Glucocorticoids는 RAA system에 의해 조절된다	✗ (Mineralocorticoids)
⑤	Cortisol은 11β-HSD 2에 의해 cortisone으로 불활성화된다	✓

핵심 암기: 11β-HSD **1** = cortisone(inactive) → cortisol(active) / 11β-HSD **2** = cortisol(active) → cortisone(inactive)

Q36 [2022 신규 추가]

다음 중 쿠싱 증후군을 **진단**하기 위한 검사는?

번호	보기	용도
①	Serum IGF-1	Acromegaly
②	Urinary 17-ketosteroids	알도스테론혈증
③	Oral glucose tolerance test	Acromegaly
④	Normal saline infusion test	알도스테론혈증 확진
⑤	Low dose dexamethasone suppression test	쿠싱 확진 ✓

🔴 선별검사: 24h urinary free cortisol(외래), overnight DEX test(입원) / 확진: Low dose DEX test

갑상선 종양 (김보현) — 35 → 40문제 (+5)

Q36-Q40이 추가되었으나 전체 갑상선 섹션은 교수 동일(김보현)하므로 참고로만 언급합니다.

✗ 삭제된 문제 (구버전에만 있음)

부신 섹션에서 삭제된 문제는 없습니다 (모든 구버전 문제가 신버전에 그대로 유지됨).

구버전 출족(2) 대비 신버전에서 **섹션 자체가 빠진 것**:

- 갑상선염 (⊖ 비교불가였던 섹션 — 신버전 목차에서 제거됨)
- 이동원 - 성분화 이상 (⊖ 비교불가)
- 강아름 - 부신 기능저하증 / 부신 증례 (교수 변경: 강아름 → 김상수)
- 강양호 - 쿠싱증후군 (독립 섹션 → 강양호 부신 질환 섹션으로 통합)

📝 해설 변경된 문제

부신흔르몬 생리 Q1 (연도 미상 — cortisol 기능 + hypersecretion)

	구버전	신버전
문제 표현	"부신 수질 에서 분비되는 stress hormone인 cortisol"	"부신 겉질 에서 분비되는 stress hormone인 cortisol"
해설 추가	—	"2023: 해설 내용은 다른 수업내용에서도 도움이 되니 꼭 읽어보시길 바랍니다"

⚠ **오타 수정**: cortisol은 부신 수질(medulla)이 아니라 **부신 겉질(cortex)**에서 분비. 구버전의 오류가 신버전에서 수정됨.

강양호 Q19 (21-hydroxylase 돌연변이)

- 신버전 코멘트 추가: "2023) 교수님께서 수업시간에 언급하셨던 문제입니다. 암기!" → 2024년에도 중요도 高

강양호 Q32/Q33 (Adrenogenital syndrome, 2021-1)

- 신버전 코멘트 추가: "2023) 어라 권상모 교수님 출갑습니다? 한번더 보면서 머릿속에 남겨놓아요~"
- **의미**: 1교시 권상모와 2교시 강양호 파트 간 출제가 겹치는 토픽 — 특히 **Adrenogenital syndrome** 기전은 양 교수님 모두에서 출제됨

강양호 Q4 (쿠싱 Cushing's disease 치료)

- 신버전 추가: "쿠싱 증후군 치료는 TSA(Trans-Sphenoidal Approach)!"

출제 경향 변화

토픽	구버전	신버전	변화
Cortisol 4가지 기능	★★★★	★★★★	유지 (매년 출제)
Adrenogenital syndrome 기전	★★★★	★★★★	유지 (양 교수님 공통, 2021에 2회 출제)
HPA axis negative feedback (CRH-ACTH-cortisol)	★★★★	★★★★	유지
Generalized Stress Response	없음	★★	신규 진입 (2022)
11β-HSD 1/2 구분	★★	★★★★	강화 (2022 "옳은 것" 문제로 변형)
쿠싱 진단검사 (선별 vs 확진 구분)	★★★★	★★★★★	강화 (2022에 단독 문제)
21-hydroxylase deficiency	★★	★★★★	강화 (작성자 "암기!" 강조)
Aldosterone 기능 (mineralocorticoid)	★★	★★	유지
Aromatase	★	★	유지 (2021-2 단독 출제)

올해 시험 대비 전략 업데이트

신버전 기준 최우선 암기 항목 (10/26 범위)

[1교시 권상모 - 부신피하선 생리]

1. **Cortisol의 4가지 기능** — 매년 필수
2. Metabolic effect (혈당 유지)
3. Permissive actions (catecholamine, glucagon 허용)
4. Stress adaptation

5. 항염증·면역억제
6. **HPA axis Negative Feedback 3패턴** (시상하부/뇌하수체/부신 문제별 CRH-ACTH-cortisol 수치 조합) — 2015·2019·2020 반복 출제
7. **Adrenogenital syndrome 기전** (cortisol 효소 결핍 → ACTH↑ → androgen 과잉 → GnRH 억제 → 불임) — 거의 매년, 2021에는 1교시+2교시 두 번 출제
8. **21-hydroxylase deficiency** → aldosterone+cortisol 결핍 — 신버전에서 "암기!" 강조
9. **Generalized Stress Response 4카테고리** — 2022 신규, 올해는 가능성 낮지만 알아두기

[2교시 강양호 - 부신포르몬 종류/작용/평가]

1. **자극검사 vs 억제검사 분류표** — 매년 출제 (선지 조금씩 변형)
2. 자극: Rapid ACTH stimulation, Insulin-induced hypoglycemia, Metyrapone, CRH, Volume depletion/Sodium restriction
3. 억제: Dexamethasone (overnight/low/high dose), Normal saline infusion
4. **쿠싱 진단 알고리즘** — 선별(24h UFC, overnight DEX) → 확진(low-dose DEX) → ACTH assay → 감별(high-dose DEX)
5. **11β-HSD 1 vs 2** — 2022에 "옳은 것" 형태로 변형 출제, 선지 뒤집기 주의
6. **High-dose DEX에 억제 안 되는 질환 3가지** — Pituitary macroadenoma, Ectopic ACTH, Adrenal tumor
7. **쿠싱 감별 시 ACTH 수치 해석** — ACTH↑ = ACTH-dependent (뇌하수체 or Ectopic), ACTH↓ = ACTH-independent (부신 종양)